

INSTRUCTIVO DE USO

Sistema de Auditoría Integral en Seguridad del Paciente

Resolución 3100 de 2019 · SOGCS · Lineamientos MSPS

Para quién es

Audidores, consultores de calidad en salud, IPS y profesionales independientes que gestionan la hospitalización y la seguridad del paciente.

Qué lograras con esta herramienta

Auditar, verificar y documentar el cumplimiento de todos los estándares de Seguridad del Paciente exigidos por la Res. 3100 de 2019 — en un solo archivo, sin hojas sueltas, sin WhatsApp, sin caos.

Versión 1.0 · 2026 · Documento confidencial — uso exclusivo Audiamigos Audisalud

1. Antes de empezar

Lee esta sección completa antes de abrir el archivo. Tomarte 3 minutos aquí te ahorrará confusión después.

¿Qué es el sistema?

Es un archivo Excel (.xlsx) de 13 hojas interconectadas que te permite realizar una auditoría integral de Seguridad del Paciente. Todo está conectado: lo que ingresas en una hoja alimenta automáticamente el dashboard, el informe y los indicadores. Tú solo llenas los campos en amarillo — el sistema calcula el resto.



MUY IMPORTANTE — Lee esto primero

El archivo contiene 1.015 fórmulas activas. NUNCA borres ni sobreescribas celdas en azul claro — son cálculos automáticos. Solo edita los campos con fondo AMARILLO. Si accidentalmente borras una fórmula, cierra sin guardar y vuelve a abrir.

¿Qué necesitas para usarlo?

	Microsoft Excel 2016 o superior (Windows o Mac). También funciona en Excel Online y Google Sheets con algunas limitaciones visuales.
	Habilitar macros NO es necesario — el sistema funciona solo con fórmulas nativas de Excel.
	Conexión a internet solo si vas a usar la integración con Google Drive para subir evidencias.
	El archivo REPS del prestador consultado en el portal: reps.minsalud.gov.co

Las 13 hojas del sistema

Navega por las pestañas de la parte inferior de Excel. Cada pestaña tiene su propio color para identificarla rápido:

PESTAÑA	COLOR	PARA QUÉ SIRVE
INICIO	Dorado	Dashboard ejecutivo con KPIs, diagnóstico automático e índice de navegación
CONFIG	Azul oscuro	Datos del prestador — DILIGENCIAR PRIMERO. Alimenta todas las hojas
REPS	Cian	Verificación frente al portal REPS: 157 servicios con menú desplegable
HABILITACION	Verde	Lista de chequeo: 61 ítems de la Res. 3100 con evidencias

		y alertas
RIESGOS	Naranja	Matriz de riesgos por servicio con mapa de calor automático
EVENTOS	Rojo	Registro de eventos adversos e incidentes con ID automático
REPORTE_EA	Vino	Protocolo de Londres + Espina de Pescado (Ishikawa) por evento
PLAN_MEJORA	Morado	Plan de mejora con alertas de vencimiento automáticas
AUDITORIA	Teal	Auditoría SP: 10 dominios, 62 criterios Res.3100/SOGCS + firmas
DASHBOARD	Gris oscuro	Gráficos e indicadores automáticos conectados a todas las hojas
INFORME	Verde	Texto ejecutivo generado automáticamente — copiar y pegar en Word
IA_DRIVE	Gris	Guía de integración con Google Drive, IA y flujo por cliente
_CATALOGOS	Oculto	Catálogo de los 157 servicios REPS y listas de validación — no modificar



Convención de colores del archivo

AMARILLO = campo editable (aquí escribes tú) · AZUL CLARO = calculado automáticamente (no editar) · ▼ en el encabezado = menú desplegable disponible · 🔗 = columna para pegar enlace de Google Drive

2. Flujo de uso paso a paso

Sigue estos 10 pasos en orden. Cada paso construye sobre el anterior. Saltarte el paso 1 causará que el nombre del prestador no aparezca en ninguna hoja.

PASO 01 CONFIGURAR EL PRESTADOR

Hoja CONFIG — Hazlo PRIMERO, antes de cualquier otra cosa

Esta hoja es el corazón del sistema. Los datos que ingresas aquí se propagan automáticamente a TODAS las demás hojas, al dashboard, al informe ejecutivo y al encabezado dinámico.

Campos a completar:

- Nombre / Razón Social del prestador
- NIT o cédula (sin puntos ni guiones)
- Tipo de prestador: selecciona del menú ▼ (IPS / Profesional Independiente / Transporte / OSD)
- Municipio y departamento
- Nombre de la sede y código REPS
- Nombre del auditor o consultor responsable
- Fecha de la auditoría (DD/MM/AAAA)
- Objetivo y alcance de la auditoría



Cómo verificar que funcionó

Abre la hoja INICIO. El encabezado dorado debe mostrar el nombre del prestador, NIT, municipio y fecha que acabas de ingresar. Si aparece así, todo está conectado correctamente.

PASO 02 VERIFICAR EL REPS

Hoja REPS — Consulta el portal y completa servicio por servicio

Abre el portal REPS en paralelo: reps.minsalud.gov.co. Busca el prestador por NIT y compara cada servicio registrado con los estándares.

Cómo diligenciar la sección de Servicios Habilitados:

1. En la columna B selecciona el GRUPO del servicio desde el menú ▼ (Internación, Quirúrgicos, Consulta Externa, etc.)
2. En la columna C selecciona el SERVICIO desde el menú ▼ — el sistema tiene los 157 servicios del catálogo oficial REPS
3. Completa modalidad ▼, complejidad ▼, horario y número de distintivo de habilitación
4. En la columna J selecciona si el servicio COINCIDE con el REPS consultado (Sí / No / Parcial)
5. En la columna K selecciona si el servicio CUMPLE los estándares de la Res. 3100 (Sí / No / Parcial)
6. La columna M muestra la alerta automática: OK / No coincide / No cumple
7. En la columna O pega el enlace de Google Drive con la evidencia si la tienes

Sección Capacidad Instalada:

- Registra la cantidad declarada en REPS y la cantidad real verificada en visita
- La columna Diferencia se calcula sola — en rojo si hay faltante, en naranja si hay exceso



Consejo profesional

Toma captura de pantalla del portal REPS para cada servicio y súbela a una carpeta de Google Drive. Pega los enlaces en la columna O. Así tienes trazabilidad completa de la verificación.

PASO 03 DILIGENCIAR LA LISTA DE CHEQUEO

Hoja HABILITACION — 61 ítems de la Res. 3100

Esta es la hoja más importante del proceso de habilitación. Evalúa ítem por ítem el cumplimiento de todos los estándares exigidos, organizados en 13 categorías según la Res. 3100 de 2019.

Cómo diligenciar cada ítem:

8. Lee el ÍTEM en la columna B — describe exactamente qué debes verificar
9. Consulta el MODO DE VERIFICACIÓN en la columna G — te dice exactamente qué evidencia necesitas
10. En la columna D selecciona del menú ▼: Cumple / No Cumple / En Proceso / No Aplica
11. Escribe el nombre del RESPONSABLE en la columna E
12. Registra la FECHA de la verificación en la columna F
13. Pega el enlace de Drive con la evidencia en la columna H ()
14. La columna I muestra la alerta automática:  OK /  En proceso /  No cumple
15. Agrega observaciones adicionales en la columna J

Categorías de la Res. 3100 cubiertas	Nº de ítems
Plataforma estratégica del programa	3 ítems
Cultura de seguridad	1 ítem
Reporte y gestión de eventos adversos	2 ítems
Prácticas seguras (IAAS, medicamentos, identificación, caídas, etc.)	35 ítems
Procesos asistenciales seguros	4 ítems
Gestión documental	4 ítems
Comunicación con el paciente	4 ítems
Monitorización e indicadores	2 ítems
Revisión por la dirección	4 ítems
Binomio madre-hijo y seguridad transfusional	2 ítems



Ítems 'No Aplica'

Usa 'No Aplica' solo cuando el ítem realmente no corresponde al tipo de prestador o los servicios habilitados. Por ejemplo: ítems de cirugía segura para un prestador sin quirófanos. No lo uses para 'no lo hemos implementado' — eso es 'No Cumple'.

PASO 04 VALORAR LOS RIESGOS

Hoja RIESGOS — Probabilidad × Impacto por servicio

El sistema tiene 27 riesgos predefinidos organizados por tipo de servicio. Evalúa cada uno con probabilidad e impacto para que el nivel de riesgo se calcule automáticamente.

Escala de valoración:

VALOR	NIVEL	NIVEL DE RIESGO	COLOR
1	Muy Bajo	≤7 — BAJO	 Verde
2	Bajo	8–14 — MODERADO	 Amarillo
3	Medio	15–19 — ALTO	 Naranja
4	Alto	≥20 — EXTREMO	 Rojo
5	Muy Alto		

Para cada riesgo: selecciona PROBABILIDAD (columna D) e IMPACTO (columna E) del menú ▼ con valores 1–5. El sistema calcula automáticamente el nivel P×I y muestra la clasificación en color. Escribe el control actual, responsable y plan de acción en las columnas C, H e I.

El MAPA DE CALOR al final de la hoja muestra la distribución visual de todos los riesgos identificados — úsalo en tus presentaciones al cliente.

PASO 05 REGISTRAR EVENTOS ADVERSOS*Hoja EVENTOS — Si el prestador tiene eventos, regístralos aquí*

Si durante la auditoría identificas eventos adversos, incidentes o near miss ocurridos en el período evaluado, regístralos en esta hoja. Si no hay eventos, puedes omitir este paso.

Cómo registrar un evento:

- La columna A genera el ID automáticamente (EA-001, EA-002...) cuando ingresas la fecha en columna B
- Selecciona el SERVICIO desde el menú ▼ (columna C) — incluye los 157 servicios del catálogo REPS
- Selecciona TURNO ▼, TIPO DE EVENTO ▼ y GRAVEDAD ▼ usando los menús desplegables
- Escribe una descripción clara del evento en la columna F
- En la columna L selecciona el ESTADO DE ANÁLISIS ▼: Pendiente / En Análisis / Cerrado
- Pega enlace de Drive con documentación en la columna M

**Eventos graves y centinela**

Si el evento es de gravedad 'Catastrófico', 'Muerte' o tipo 'Evento Centinela', la celda se marca automáticamente en rojo oscuro. Estos eventos DEBEN analizarse con el Protocolo de Londres en la hoja REPORTE_EA y notificarse a SIVIGILA según corresponda.

PASO 06 ANALIZAR EVENTOS CON PROTOCOLO DE LONDRES*Hoja REPORTE_EA — Un formulario por cada evento adverso*

Para cada evento adverso registrado en la hoja EVENTOS, especialmente los graves o centinela, debes completar un análisis en esta hoja. El formulario tiene tres grandes secciones:

SECCIÓN 1	Identificación del caso: sede, fechas, origen del reporte, descripción del evento, acciones inmediatas tomadas
SECCIÓN 2	Investigación con Protocolo de Londres: acciones inseguras + 7 factores contributivos (paciente, tarea/tecnología, individuo, equipo, ambiente, organización, contexto)
SECCIÓN 3	Espina de Pescado (Ishikawa): causas por las 7 categorías → causa raíz identificada
SECCIÓN 4	Plan de acción: acciones, responsables, fechas y seguimiento del auditor

Cómo diligenciar la Espina de Pescado:

- Para cada categoría de factor (DEL PACIENTE, DE LA TAREA, DEL INDIVIDUO, etc.) escribe hasta 3 causas específicas identificadas en el análisis
- Al final, sintetiza la CAUSA RAÍZ en el campo resaltado en rojo — esta es la causa de fondo, no el síntoma
- La causa raíz debe responder a la pregunta: ¿por qué ocurrió realmente? No ¿qué pasó?



Recomendación para equipos

Imprime o comparte este formulario con el equipo del prestador para diligenciarlo en conjunto. El análisis de causa raíz es más preciso cuando participan las personas que estuvieron involucradas en el evento.

PASO 07 CONSTRUIR EL PLAN DE MEJORA

Hoja PLAN_MEJORA — Centraliza todas las acciones

Aquí consolidas todas las acciones de mejora identificadas durante la auditoría: las que vienen de la lista de chequeo, de la matriz de riesgos, del análisis de eventos y de las observaciones adicionales.

Cómo registrar cada acción:

- Columna B: describe el hallazgo u oportunidad de mejora que genera la acción
- Columna C: describe la acción específica que debe ejecutarse
- Columna D: nombre del responsable de implementar la acción
- Columna E: área o proceso al que pertenece
- Columnas F y G: fecha de inicio y fecha límite — las fechas vencidas se marcan automáticamente en ROJO
- Columna I: selecciona el estado ▼ (Pendiente / En Proceso / Completado / Cerrado)
- Columna L: pega el enlace Drive con la evidencia de cierre



Fechas límite vencidas

Cuando una fecha límite pasa sin que el estado sea 'Cerrado', la celda de fecha se pinta automáticamente en ROJO. El contador de ACCIONES VENCIDAS en la parte superior se actualiza en tiempo real. Revisa este indicador en cada seguimiento.

PASO 08 COMPLETAR LA AUDITORÍA INTEGRAL SP

Hoja AUDITORIA — 10 dominios, 62 criterios

Esta hoja consolida la auditoría completa del Programa de Seguridad del Paciente. A diferencia de la lista de chequeo (que verifica la documentación), aquí evalúas el estado del programa como sistema.

Los 10 dominios que evalúa:

#	DOMINIO	CRITERIOS CLAVE
1	Plataforma Estratégica SP	Política, programa, comité, presupuesto y plan de trabajo
2	Cultura de Seguridad	Encuesta, capacitaciones, política no penalización, rondas directivas
3	Reporte y Gestión de EA	Sistema de reporte, Protocolo de Londres, SIVIGILA, revisión por dirección
4	Prácticas Seguras Obligatorias	Identificación, comunicación, medicamentos, IAAS, cirugía, caídas, UPP, binomio madre-hijo, transfusional
5	Gestión del Riesgo	Valoración, AMFE, planes de acción, revisión semestral
6	Indicadores y Monitorización	SISPRO, ISQ, caídas, UPP, medicamentos, centinelas, satisfacción
7	Procesos Asistenciales Seguros	GPC, adherencia, protocolos alto riesgo, listas de chequeo
8	Gestión Documental	Manual SP, formatos, actas, historias clínicas
9	Comunicación con el Paciente	Consentimiento informado, educación, participación, PQRS
10	Revisión por la Dirección	Revisión SGC, junta directiva, informe de gestión, compromisos

Para cada criterio selecciona del menú ▼: Cumple / No Cumple / En Proceso / No Aplica. El sistema calcula automáticamente el porcentaje de cumplimiento del programa y muestra el semáforo Verde / Amarillo / Rojo.

La sección de FIRMAS al final requiere: Auditado / Representante Legal, Auditor / Consultor, Director o Gerente, y Jefe de Calidad / SP. Fecha y cargo de cada uno.

PASO 09 REVISAR EL DASHBOARD E INDICADORES

Hoja DASHBOARD — Todo calculado automáticamente

Una vez que hayas diligenciado las hojas anteriores, el Dashboard muestra en tiempo real todos los indicadores de la auditoría. No necesitas ingresar nada aquí — solo leer e interpretar.

Indicadores que verás:

- % Servicios que cumplen Res. 3100 vs. meta 80%
- % Servicios que coinciden con el portal REPS
- % Cumplimiento de la lista de chequeo de habilitación
- Número de eventos adversos registrados y sin análisis
- Número de riesgos extremos y altos identificados
- % Acciones del plan de mejora cerradas
- Semáforo global: Verde / Amarillo / Rojo con interpretación
- Gráfico de barras: cumplimiento por módulo vs. meta
- Gráfico de torta: distribución de ítems (Cumple / No Cumple / En Proceso / Pendiente)
- Resumen del programa SP desde la hoja AUDITORIA



Para presentaciones

El Dashboard es la página que debes mostrarle a la dirección del prestador. Toma una captura de pantalla o imprime solo esta hoja (Diseño de página → Área de impresión → Imprimir hoja activa) para tus presentaciones ejecutivas.

PASO 10 GENERAR Y ENTREGAR EL INFORME

Hoja INFORME — Texto ejecutivo listo para copiar

La hoja INFORME genera automáticamente el texto completo del informe ejecutivo con todos los datos de la auditoría. El proceso es simple:

29. Abre la hoja INFORME
30. Verifica que el encabezado tenga los datos correctos del prestador (vienen de CONFIG)
31. Lee el texto generado automáticamente en las secciones: REPS, Habilitación, Eventos, Riesgos y Plan de Mejora
32. Copia todo el contenido (Ctrl+A, Ctrl+C)
33. Pégallo en un documento Word o Google Docs para darle formato final
34. Completa las firmas en la hoja AUDITORIA (requieren firma física o digital del prestador y el auditor)



Antes de entregar el informe, verifica:

1. Datos del prestador correctos en CONFIG · 2. Todas las hojas con los campos necesarios diligenciados · 3. Semáforo del Dashboard refleja la realidad auditada · 4. Firmas obtenidas en la hoja AUDITORIA · 5. Evidencias subidas a Google Drive y enlaces pegados en las columnas 

3. Cómo gestionar las evidencias en Google Drive

Cada ítem que evalúes debe respaldarse con evidencia documental. El sistema tiene columnas  en las hojas REPS, HABILITACION, RIESGOS, EVENTOS y PLAN_MEJORA para pegar los enlaces directos a cada documento.

Estructura de carpetas recomendada en Drive

	Cientes / [Nombre IPS] / [AñoMes] → carpeta raíz del cliente
	→ Evidencias / REPS / HABILITACION / Eventos / Plan_Mejora
	→ Informe_Final / → Herramienta_[NombreIPS]_[Fecha].xlsx
	→ Actas / → Fotos_Visita / → Documentos_Prestador

Cómo copiar el enlace de un archivo en Drive

35. Sube el archivo a la carpeta correspondiente en Google Drive
36. Haz clic derecho sobre el archivo → selecciona Compartir u Obtener enlace
37. Cambia el acceso a Cualquier persona con el enlace puede ver
38. Copia el enlace
39. Pégallo en la celda  correspondiente dentro del archivo Excel
40. Para abrirlo desde Excel: Ctrl + Clic sobre la celda con el enlace



Sobre la privacidad de las evidencias

Las evidencias de habilitación contienen información sensible del prestador. Configura las carpetas de Drive como Restringido (solo personas con acceso específico) y comparte solo con el equipo que necesita verlas. Nunca uses enlaces públicos para documentos con datos de pacientes.

4. Cómo potenciar el sistema con IA

El sistema fue diseñado para trabajar junto con herramientas de Inteligencia Artificial. Aquí tienes prompts listos para usar en ChatGPT, Claude u otras IA.

Prompts listos para copiar y usar

Analizar hallazgos de habilitación

"Eres auditor experto en Resolución 3100 de 2019 y habilitación de servicios de salud en Colombia. Analiza estos hallazgos de mi auditoría: [pega la tabla de hallazgos de la hoja AUDITORIA]. Redacta un informe ejecutivo de 3 párrafos para presentar a la gerencia con: resumen del estado actual, 3 hallazgos críticos priorizados y 5 recomendaciones accionables."

Analizar causa raíz de un evento adverso

"Usando el Protocolo de Londres, ayúdame a analizar el siguiente evento adverso: [describe el evento]. Identifica las posibles causas en cada una de estas 7 categorías: del paciente, de la tarea/tecnología, del individuo, del equipo de trabajo, del ambiente, de la organización/gerencia, del contexto institucional. Propón 3 acciones correctivas con responsable, indicador de éxito y plazo."

Redactar un plan de mejora

"Para el hallazgo [describe el hallazgo específico] identificado en la categoría [nombre la categoría] de la Resolución 3100 de 2019, propón 3 acciones de mejora concretas. Para cada acción incluye: descripción de la acción, tipo (Correctiva/Preventiva), responsable sugerido, indicador de éxito medible y plazo en días."

Preparar una política de SP

"Redacta una Política de Seguridad del Paciente para una [tipo de prestador] con servicios de [lista los servicios habilitados], ubicada en [municipio]. La política debe incluir: objetivo, alcance, principios orientadores, compromisos de la alta dirección, mecanismos de reporte y responsables. Extensión máxima: 1 página. Formato Word profesional."

5. Preguntas frecuentes

P: ¿Por qué el nombre del prestador no aparece en el INICIO?

R: Porque aún no has completado la hoja CONFIG. Abre esa hoja, llena al menos el campo Nombre / Razón Social y la fecha de auditoría, y vuelve al INICIO — debería actualizarse automáticamente.

P: ¿Puedo usar el archivo para varios clientes al tiempo?

R: Sí, pero debes duplicar el archivo por cada cliente. Nunca uses el mismo archivo para dos prestadores diferentes. Renombra la copia con el formato: Auditoria_[NombreIPS]_[AñoMes].xlsx antes de empezar.

P: ¿Por qué algunos campos en azul muestran --?

R: Eso significa que la hoja de origen aún no tiene datos. Por ejemplo, si el DASHBOARD muestra -- en el KPI de habilitación, es porque la hoja HABILITACION no tiene ningún ítem evaluado todavía. Diligencia la hoja correspondiente y el valor aparecerá automáticamente.

P: ¿Puedo agregar más servicios de los que tiene la lista?

R: La lista de 157 servicios cubre el catálogo oficial REPS completo. Si tienes un servicio que no aparece, selecciona el más parecido en el menú y anota la diferencia en la columna Observaciones.

P: ¿Qué pasa si borro accidentalmente una fórmula?

R: Cierra el archivo sin guardar (Ctrl+Z varias veces o File → Close → Don't Save) y vuelve a abrirlo. Por eso es importante no guardar inmediatamente si ves un valor extraño. Para prevenir esto: antes de entregar, guarda una copia de respaldo en Drive.

P: ¿El archivo funciona en Google Sheets?

R: Sí, con limitaciones. Los menús desplegables funcionan. Los gráficos pueden verse ligeramente diferentes. El formato condicional (colores automáticos) funciona en la mayoría de los casos. Si usas Google Sheets, sube el archivo .xlsx directamente y ábrelo con Google Sheets — no lo conviertas.

P: ¿Cómo imprimo solo la hoja de informe?

R: Abre la hoja INFORME, ve a Diseño de página → Área de impresión → Establecer área de impresión, selecciona el rango con el texto del informe y luego Archivo → Imprimir. Los márgenes están configurados para impresión en A4 horizontal.

P: ¿Puedo modificar los criterios de la hoja AUDITORIA?

R: Los criterios están basados en la Res. 3100 de 2019, el SOGCS y los lineamientos del MSPS. No se recomienda modificarlos. Si necesitas agregar criterios específicos de tu institución, úsalos en la sección Hallazgos Adicionales de la hoja AUDITORIA.

6. Glosario rápido

TÉRMINO	DEFINICIÓN
Res. 3100 de 2019	Resolución del MinSalud que define los estándares del Sistema Único de Habilitación (SUH) para prestadores de servicios de salud en Colombia
SOGCS	Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud — marco regulatorio de la calidad en salud en Colombia (Decreto 1011/2006)
REPS	Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud — base de datos oficial del MinSalud con todos los prestadores habilitados
Evento Adverso (EA)	Daño no intencional causado al paciente durante o como resultado de la atención en salud, no relacionado con la enfermedad de base
Incidente	Situación de riesgo que podría haber causado daño al paciente pero no lo causó, ya sea por casualidad o por intervención oportuna
Near Miss	Incidente que no llegó al paciente — se detectó y controló antes de producir consecuencias
Evento Centinela	Evento adverso que resulta en muerte inesperada, lesión física o psicológica grave o riesgo de ello. Requiere análisis inmediato
Protocolo de Londres	Metodología de análisis de incidentes clínicos adoptada por el MinSalud para identificar causas raíz de eventos adversos
Espina de Pescado (Ishikawa)	Diagrama de causa y efecto que permite identificar visualmente las causas de un problema en 7 categorías de factores contributivos
IAAS	Infecciones Asociadas a la Atención en Salud — infecciones que se desarrollan durante la hospitalización o atención en salud
PAMEC	Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad — componente del SOGCS que orienta los procesos de mejora continua
SISPRO	Sistema Integral de Información de la Protección Social — plataforma donde se reportan los indicadores de calidad en salud
SIVIGILA	Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública — sistema de notificación obligatoria de eventos de salud pública en Colombia
Trazadores de calidad	Indicadores priorizados del SOGCS que reflejan el desempeño del sistema de salud y deben reportarse mensualmente a SISPRO

AUDISALUD COLOMBIA SAS

Experiencia en Calidad y Auditoría

gerenciaaudisalud@gmail.com · www.audisalud.com · @audisaludcol

Este instructivo es de uso exclusivo de los compradores de la Herramienta de Auditoría Integral en Salud de Audisalud. Queda prohibida su reproducción, distribución o comercialización sin autorización escrita de Audisalud Colombia SAS.

© Audisalud Colombia SAS · 2026 · Todos los derechos reservados